

กรณีศึกษาที่ 3

สมรรถนะ RDU ของบัณฑิต

1. สามารถประเมินปัญหาผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา หรือมีความจำเป็นต้องใช้ยาในการรักษา
 - 1.1 การประเมินประวัติโรคประจำตัว ประวัติการใช้ยา และประวัติการแพ้ยา/แพ้ อาหาร
 - 1.2 ประเมินอาการข้างเคียงจากการใช้ยา
 - 1.3 ประเมินอาการที่ขึ้นหรือเลวลง
 - 1.4 ติดตามความร่วมมือในการใช้ยา อย่างต่อเนื่อง
 - 1.5 การส่งต่อ
2. สามารถร่วมพิจารณาการเลือกยาได้อย่างเหมาะสมตามความจำเป็น
 - 2.1 พิจารณาข้อมูลที่สำคัญของผู้ป่วยที่ เกี่ยวข้องกับการเลือกยาหรือการรักษาแบบไม่ใช้ยาในการรักษา และการส่งเสริมสุขภาพ
 - 2.2 พิจารณาข้อมูลที่สำคัญของผู้ป่วยเพื่อประกอบการปรับขนาดยา หยุดการให้ยา หรือเปลี่ยนยา
 - 2.3 ประเมินความเสี่ยงและประโยชน์ของการใช้ยาและไม่ใช้ยา
 - 2.4 ใช้ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ของยาที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จากปัจจัยต่อไปนี้ เช่น พันธุกรรม อายุ ความพร้อมของไต การตั้งครรภ์ ฯลฯ เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยา
 - 2.5 พิจารณาโรคร่วม ยาที่ใช้อยู่ การแพ้ยา ข้อห้ามการใช้ยา และคุณภาพชีวิต ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การเลือกใช้ยา
 - 2.6 คำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาของผู้ป่วย (เช่น ความสามารถในการกลืนยา ศาสนา) และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากวิธีการบริหารยา
 - 2.7 พัฒนาความรู้ให้เป็นปัจจุบัน ใช้แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และคำนึงถึงความคุ้มค่า ในการพิจารณาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
 - 2.8 เข้าใจเรื่องเชื้อดื้อยา แนวทางการป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยา (antimicrobial stewardship measures)
- 3.สามารถสื่อสารเพื่อให้ผู้ป่วยร่วมตัดสินใจในการใช้ยา โดยพิจารณาจากข้อมูลทางเลือกที่ถูกต้องเหมาะสมกับ บริบทและเคารพในมุมมองของผู้ป่วย
 - 3.1 ชี้แจงทางเลือกในการรักษา ยอมรับ ในการตัดสินใจเลือกแผนการรักษาและ เคารพในสิทธิของผู้ป่วย/ ผู้ดูแล ในการปฏิเสธและจำกัดการรักษา
 - 3.2 ระบุและยอมรับความแตกต่าง ระหว่างบุคคล ค่านิยม ความเชื่อ และความคาดหวัง เกี่ยวกับสุขภาพ และการรักษาด้วยยา
 - 3.3 อธิบายเหตุผล และความเสี่ยง/ประโยชน์ของทางเลือกในการรักษาที่ ผู้ป่วย/ผู้ดูแล เข้าใจได้

3.4 ประเมินความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ด่วนตัดสินและเข้าใจเหตุผลในการไม่ร่วมมือของผู้ป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้และหาวิธีที่ดีที่สุดในการสนับสนุนผู้ป่วย/ผู้ดูแล

3.5 สร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย/ ผู้เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยไม่คาดหวังว่าการสั่งยานั้นจะเป็นไปตามที่ต้องการ

3.6 ทำความเข้าใจกับการร่วมปรึกษาหารือก่อนใช้ยาเพื่อผลลัพธ์ที่นำไปสู่ ความพึงพอใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

4. บริหารยาตามการสั่งใช้ยาได้อย่างถูกต้อง

4.1 เข้าใจโอกาสที่จะเกิดผลไม่พึง ประสงค์จากการใช้ยา และดำเนินการเพื่อ หลีกเลี่ยง/ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ตรวจจับและจัดการแก้ไขปัญหา

4.2 เข้าใจการสั่งจ่ายยาของแพทย์ตาม กรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ

4.3 ตรวจสอบและคำนวณการใช้ยาให้ ถูกต้อง

4.4 คำนึงถึงโอกาสที่จะเกิดการใช้ยาผิด (เช่น ผิดขนาด ผิดทาง ผิดวิธี ผิดชนิด ผิด วัตถุประสงค์ ฯลฯ)

4.5 ใช้ข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับการใช้ยา อย่างสมเหตุผล (เช่น การเก็บรักษา การ บรรจุ ฯลฯ)

4.6 ใช้ระบบที่จำเป็นเพื่อการบริหารยา อย่างมีประสิทธิภาพ (เช่น ใบMAR)

4.7 สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับยาและการใช้ ยาแก่ผู้เกี่ยวข้องเมื่อต้องมีการส่งต่อข้อมูล การรักษา

5. สามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้ยาได้อย่างเพียงพอ (Provide information)

5.1 ตรวจสอบความเข้าใจและความ มุ่งมั่นตั้งใจของผู้ป่วย/ผู้ดูแลในการจัดการ เฝ้าระวังติดตาม และการมาตรวจตามนัด

5.2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ชัดเจน เข้าใจ ได้ง่าย และเข้าถึงได้กับผู้ป่วย/ผู้ดูแล (เช่น ใช้เพื่ออะไร ใช้อย่างไร อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น รายงานอย่างไร ระยะเวลาของ การใช้ยา)

5.3 แนะนำผู้ป่วย/ผู้ดูแลเกี่ยวกับ แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ในเรื่องยาและการ รักษา

5.4 สร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วย/ผู้ดูแล ว่าจะจัดการอย่างไรในกรณีที่มีอาการไม่ดีขึ้น หรือการรักษาไม่ก้าวหน้าในช่วงเวลาที่กำหนด

5.5 สนับสนุนผู้ป่วย/ผู้ดูแลให้มีส่วนรับผิดชอบในการจัดการตนเองเรื่องยาและภาวะเจ็บป่วย

6. สามารถติดตามผลการรักษา และรายงานผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยาได้

6.1 ทบทวนแผนการบริหารยาให้ สอดคล้องกับแผนการรักษาที่ผู้ป่วยได้รับ

6.2 ต้องมีการติดตามประสิทธิภาพของการรักษาและอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น จากการใช้ยา

6.3 ค้นหาและรายงานอาการไม่พึง ประสงค์จากการใช้ยาโดยใช้ระบบการรายงานที่เหมาะสม

6.4 ปรับแผนการบริหารยาให้ตอบสนองต่ออาการและความต้องการของผู้ป่วย

7. สามารถใช้ยาได้อย่างปลอดภัยทั้งต่อผู้ป่วย และไม่เกิดผลกระทบต่อสังคมโดยรวม (Prescribe safely)

7.1 รู้เกี่ยวกับชนิด สาเหตุของความคลาดเคลื่อนทางยาที่พบบ่อย และ วิธีการป้องกัน การหลีกเลี่ยง และการประเมิน

7.2 ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการสั่งยาผ่านสื่อหรือบุคคลอื่น เช่น สั่งทาง โทรศัพท์ ทาง E-mail ทาง Line หรือสั่งผ่านบุคคลที่สาม และหาแนวทางลดความเสี่ยงนั้น

7.3 บริหารยาอย่างปลอดภัยตามกระบวนการบริหารยา เช่น 7 rights

7.4 พัฒนาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ในประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความ ปลอดภัยในการใช้ยา

7.5 รายงานความคลาดเคลื่อนในการใช้ยา และทบทวนการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ

8. สามารถใช้ยาได้อย่างเหมาะสม ตามความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ และเป็นไปตามหลักเวชจริยศาสตร์ (Prescribe professionally)

8.1 มั่นใจว่าพยาบาลสามารถสั่งจ่ายยาได้ ตาม พรบ.วิชาชีพและ พรบ.ยาแห่งชาติ

8.2 ยอมรับความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการสั่งยาและเข้าใจในประเด็นกฎหมายและจริยธรรม

8.3 รู้และทำงานภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการสั่งยา (ยาที่ควบคุม ยาที่ไม่มีใบอนุญาต ยาไม่มีฉลาก)

9. สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ยาได้อย่างต่อเนื่อง (Improve prescribing practice)

9.1 สะท้อนคิดการบริหารยาของตนเอง และการสั่งยาของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

9.2 เข้าใจและใช้เครื่องมือหรือกลไกที่เหมาะสมในการปรับปรุงการบริหารยาและการสั่งยา (เช่น patient and peer review feedback, prescribing data and analysis and audit)

10. สามารถทำงานร่วมกับบุคลากรอื่นแบบสหวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Prescribe as part of a team)

10.1 มีส่วนร่วมกับสหวิชาชีพเพื่อให้มั่นใจว่าการดูแลมีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงกันในทุกหน่วยโดยไม่ขัดแย้ง

10.2 สร้างสัมพันธภาพกับทีมสหวิชาชีพ บนพื้นฐานของความเข้าใจ ความไว้วางใจ และยอมรับในบทบาทของสหวิชาชีพ

ประเด็นที่สอดคล้องกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการปฏิบัติการพยาบาล 17 ประเด็น ดังนี้

1) National Drug Policy (NDP) and concepts of RDU	1) นโยบายยาแห่งชาติ (NDP) และแนวความคิดของ RDU
2) Basic pharmacology (Pharmacodynamics) and Clinical pharmacokinetics	2) เภสัชวิทยาพื้นฐาน (เภสัช) และเภสัชจลนศาสตร์คลินิก
3) Irrational/ inappropriate use of medicine	3) การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล/ ไม่เหมาะสม
4) Monitoring and evaluation impact of drug therapy	4) การติดตามและประเมินผลกระทบของการบำบัดด้วยยา
5) Adherence to treatment	5) การปฏิบัติตามการรักษา
6) Benefit-risk and cost assessment and decision making in prescription	6) การประเมินผลประโยชน์-ความเสี่ยงและต้นทุนและการตัดสินใจในใบสั่งยา
7) RDU in common illness	7) RDU ในความเจ็บป่วยทั่วไป
8) Taking an accurate and informative drug history	8) การซักประวัติยาที่ถูกต้องและให้ข้อมูล
9) Administer drug safely	9) ใช้ยาอย่างปลอดภัย
10) Medication errors	10) ข้อผิดพลาดของยา
11) Prescribing for patients with special requirements	11) การกำหนดให้ผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ
12) Provide patients and careers with appropriate information about their medicines	12) ให้ข้อมูลที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยและอาชีพเกี่ยวกับยา
13) Awareness of rational approach to prescribing and therapeutics	13) ความตระหนักในแนวทางที่มีเหตุผลในการสั่งจ่ายยาและการรักษา
14) Ethics of prescribing and drug promotion	14) จรรยาบรรณในการสั่งยาและส่งเสริมยา
15) Complementary and alternative medicine	15) ยาเสริมและการแพทย์ทางเลือก
16) Multi- professional care team to improve drug use	16) ทีมงานดูแลมืออาชีพ ปรับปรุงการใช้ยา
17) Continuous professional development in RDU	17) การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องใน RDU

กรอบแนวคิดในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลผล 10 ข้อ

- 1.ข้อบ่งชี้ (Indication) ใช้ยาเมื่อมีความจำเป็น (เกิดประโยชน์มากกว่าโทษ)
2. ประสิทธิภาพ (Efficacy) ยานั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง โดยอาจพิจารณาจากกลไก การออกฤทธิ์ มีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนเพียงพอ
- 3.ความเสี่ยง (Risk) คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักมีประโยชน์มากกว่าโทษ และไม่มีข้อห้ามใช้ในผู้ป่วย
- 4.ค่าใช้จ่าย (Cost) ใช้ยาอย่างพอเพียงและคุ้มค่า
- 5.องค์ประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็น (Other considerations) รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง รับผิดชอบและใช้ยาอย่างเป็นขั้นตอนตามมาตรฐานทางวิชาการ
- 6.ขนาดยา (Dose) ใช้ยาถูกขนาด
- 7.วิธีให้ยา (Method of administration)
- 8.ความถี่ในการให้ยา
- 9.ระยะเวลาในการให้ยา (Duration of treatment)
10. การยอมรับของผู้ป่วยและความสะดวกในการใช้ยา (Patient compliance)

หัวข้อการสอน การพยาบาลผู้ป่วยใช้ยาสมเหตุผล

สมรรถนะการใช้ยาสมเหตุผลที่กำหนด

1. สามารถประเมินปัญหาผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา หรือมีความจำเป็นต้องใช้ยาในการรักษา
 - 1.1 การประเมินประวัติโรคประจำตัว ประวัติการใช้ยา และประวัติการแพ้ยา/แพ้ อาหาร
 - 1.2 ประเมินอาการข้างเคียงจากการใช้ยา
 - 1.3 ประเมินอาการที่ดีขึ้นหรือเลวลง
 - 1.4 ติดตามความร่วมมือในการใช้ยา อย่างต่อเนื่อง
4. บริหารยาตามการสั่งใช้ยาได้อย่างถูกต้อง
 - 4.1 เข้าใจโอกาสที่จะเกิดผลไม่พึง ประสงค์จากการใช้ยา และดำเนินการเพื่อ หลีกเลี่ยง/ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ตระหนักและจัดการแก้ไขปัญหา

ประเด็นเนื้อหาหลักที่กำหนด (เลือกจาก 17 ประเด็นเนื้อหาหลัก)

4. Monitoring and evaluation impact of drug therapy, adverse effects properly and reporting drug related problems
5. Adherence to treatment
9. Administer drug safely
10. Medication errors
11. Prescribing for patients with special requirements

ผลการเรียนรู้ที่กำหนด

1. มีความเข้าใจในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อสื่อสารการใช้ยาอย่างสมเหตุผลกับผู้ป่วยและครอบครัวได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบายโอกาสของการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
2. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนทางยา

กระบวนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง

1. บรรยายเรื่องการบริหารยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วย (10 นาที)
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละไม่เกิน 10 คน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์กรณีศึกษาและอภิปรายในประเด็น โอกาสและการป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา ข้อพึงระวังและอาการแสดงที่สำคัญ ที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนของการใช้ยา และการสื่อสารกับผู้ป่วย ครอบครัวและผู้ดูแล เพื่อลดหรือป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา (20 นาที)
3. สุ่มนักศึกษาเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาในประเด็นที่มอบหมาย อาจารย์เพิ่มเติมในประเด็นที่นักศึกษายังอธิบายเหตุและผลไม่ชัดเจน/ไม่ถูกต้อง
4. สุ่มนักศึกษาให้แสดงบทบาทสมมติหัวข้อ การสื่อสารกับผู้ป่วย ครอบครัวและผู้ดูแล เพื่อลดหรือป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา (10 นาที)
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม(10 นาที)
6. ผู้สอนสรุปประเด็นสำคัญ (10 นาที)

สื่อการสอน

1. ใบงาน
2. กรณีศึกษา
3. กระดาษ Flip chart
4. Power point และเอกสารประกอบการเรียนในระบบ e learning
5. อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการสอน

วิธีการประเมินผล

1. ประเมินความครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน ได้ใจความของคำตอบในใบงาน
2. Quiz เมื่อสิ้นสุดการสอน

ตัวอย่างกรณีศึกษา

Dx. Psoriasis

คุณ อดิศักดิ์ อายุ 59 ปี

เริ่มมีอาการตอนอายุประมาณ 15-16 ปี มีสะเก็ดสีขาว กลางศีรษะ คิดว่าเป็นรังแค จึงเอาหัวมาหวีออก จากนั้นสะเก็ดขาวกระจายทั่วศีรษะ ไปตี๋มแอลกอฮอล์ มีอาการคันที่ผิวหนัง ผิวหนังบริเวณหน้ามีลักษณะเป็นขุยๆ จึงไปพบแพทย์ แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นผื่นที่มาจากการแพ้แอลกอฮอล์และให้ยารับประทาน อาการทุเลา

10 ปีก่อนมาโรงพยาบาล ไปป่า แล้วรับประทานปลาทุเค็มคลุกข้าว ประมาณสามคำ จากนั้นมีอาการคัน และมีตุ่มใสขึ้นทั่วตัว นอนไม่ได้ ตอนเช้าตุ่มใสบริเวณส่วนบนของร่างกายยุบ แต่บริเวณขาไม่ยุบ และค่อยๆกลายเป็นปื้นหนา แดงๆ และเริ่มลามเป็นทั้งขา จึงไปพบแพทย์ แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นสะเก็ดเงิน และให้ยารับประทาน แต่อาการไม่ดีขึ้น จึงไปรักษาตามที่ต่างๆ ไม่ว่าจะรับประทานยาสมุนไพรและทำฉายแสงอาทิตย์เทียมที่ศูนย์วิจัยแม่ฟ้าหลวง อาการไม่ทุเลา จึงเปลี่ยนไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย แพทย์ให้ยากดภูมิคุ้มกันและยาทา นัดติดตามผลทุก 3 เดือน ตรวจเลือดทุก 6 เดือน ปัจจุบันอาการดีขึ้น

ยาที่ผู้ป่วยได้รับ

- methotrexate Emthexate tab 2.5 mg q วันอังคาร เข้า 2 เม็ด เย็น 1 เม็ด
- folic acid 5 mg 1 tab OD
- Daivobet 15 g ointment ทา เข้า – เย็น
- Topicorte 0.25% cream ทา เข้า – เย็น
- Dermovate cream ทา เข้า – เย็น
- Skin cream 120 g ทา เข้า – เย็น

แนวทางการอภิปราย สมรรถนะการใช้ยาสมเหตุผลที่ 1 – 4
ประเด็นเนื้อหาหลักข้อที่ 4 – 5 – 9
กรอบแนวคิดที่ 1 – 2 – 6

1. สรรพคุณของยา และผลข้างเคียงของยา อาการและอาการแสดงเมื่อขาดยาหรือ ได้รับยามากเกินไป
2. ประวัติการใช้ยา พฤติกรรมการกินยา การซื้อยากินเอง
3. การสื่อสารกับผู้ดูแลในการใช้ยา การจัดยาให้ผู้ป่วยและการสังเกตอาการที่เกิดจาก ผลข้างเคียงของการใช้ยา

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับอาจารย์

โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรัง ชนิดหนึ่ง ลักษณะของโรคคือผื่นสีแดงค่อนข้างหนาและมีขุยสีขาว คล้ายรังแคติดที่ผิวแต่มักจะรุนแรงกว่า มีสะเก็ดออกมามากกว่า กระจายอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยร้อยละ 80 ของผู้ป่วย ผื่นสะเก็ดเงินมักเริ่มต้นที่ศีรษะก่อนจะกระจายไปยังส่วนอื่น ตำแหน่งที่พบบ่อยคือบริเวณคอกและเข่า หรือตำแหน่งที่มีการเกาหรือเสียดสี ผู้ที่เป็นโรคสะเก็ดเงินจะมีอาการคันร่วมด้วย โดยโรคสะเก็ดเงินไม่ใช่โรคติดต่อ ไม่มีการติดเชื้อและไม่แพร่เชื้อ

การรักษาโรคสะเก็ดเงินเป็นการรักษาให้โรคสงบ แต่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ หากมีสิ่งมากระตุ้นโรคจะสามารถกำเริบได้อีกโดยในการรักษาแพทย์จะเลือกรักษาตามความรุนแรง แบ่งออกเป็น

- กรณีเป็นน้อย รักษาโดยใช้ยาทาเฉพาะที่ เช่น ยา Daivobet 15 g ointment Topicorte 0.25% cream Dermovate cream Skin cream เพื่อลดอาการอักเสบ ตัวยามักมีข้อจำกัดในการใช้ จึงควรใช้ภายใต้คำแนะนำและการควบคุมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
- กรณีมีผื่นหนาและเป็นมาก รักษาโดยใช้ยากินร่วมกับยาทา หรือรักษาด้วยวิธีอื่น ได้แก่ ฉายแสงอาทิตย์เทียม
- กรณีต่อการรักษาวิธีใดอาจใช้วิธีอื่นมารักษาแทน เช่น ใช้ยาฉีดชีวภาพ

ข้อมูลยา

Daivobet ointment เป็นอนุพันธ์วิตามินดี 3 ที่สังเคราะห์ขึ้น ออกฤทธิ์จับกับ vitamin D receptors ที่ epidermal cells มีฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งเซลล์ผิวหนังในโรคสะเก็ดเงินและทำให้เซลล์มีการเปลี่ยนแปลงตามปกติ

Topicort cream เป็นยา steroid ชนิดทา รักษาโรคสะเก็ดเงิน บรรเทาอาการปวด อาการคัน ช่วยให้ความชุ่มชื้นถนอมผิว ขนาดความแรงปานกลางถึงค่อนข้างสูง หากใช้ติดต่อกันนานๆ อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงจาก steroid ได้ ดังนั้นควรหยุดใช้ยาเมื่อสามารถควบคุมอาการได้หรือหายเป็นปกติแล้ว แต่หากใช้ยาแล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรกลับไปพบแพทย์อีกครั้งหนึ่ง วิธีการใช้คือ ให้ทาบางๆบริเวณที่ต้องการรักษาวันละ 2 ครั้ง

Dermovate cream / Clobetasol

การใช้ยา

- ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
- ใช้ยานี้ให้ครบตามที่แพทย์กำหนด แม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม
- ยา Clobetasol เป็นยาสำหรับใช้กับผิวหนังเท่านั้น ห้ามนำมารับประทาน และห้ามใช้ทาบริเวณปาก จมูก และดวงตา
- ล้างมือก่อนและหลังใช้ยานี้ แต่หากใช้ยาที่มือก็ห้ามล้างมือ
- ทำความสะอาดบริเวณที่ต้องทายาให้สะอาดและเช็ดให้แห้งก่อนใช้
- ห้ามใช้ยานี้ทาลงบนใบหน้า รักแร้ หรือขาหนีบ ยกเว้นเป็นคำสั่งจากแพทย์
- ห้ามใช้ผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล หรือเครื่องสำอางบริเวณที่ใช้ยา นอกจากแพทย์จะแนะนำให้ใช้ได้
- หากลืมใช้ยา ให้ใช้ทันทีที่นึกขึ้นได้ หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยาในรอบต่อไป และห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า
- ห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่น
- แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้น หรือแย่ลง
- หากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
- ปรีกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงวิธีเก็บยาและวิธีกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสม
- เก็บยาไว้ในที่อุณหภูมิห้อง ห้ามแช่แข็ง เก็บให้พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Clobetasol

การใช้ยา Clobetasol อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง ได้แก่ ผิวแห้ง ระคายเคืองผิว แสบ และแดง หากอาการดังกล่าวไม่หายไปหรือรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์

หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยา Clobetasol ดังต่อไปนี้ ควรหยุดใช้ยาและไปพบแพทย์ทันที

- อาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก หน้าบวมริมฝีปากบวม ลิ้นบวม คอบวม ผื่นคัน ผิวหนังบวม แดง พุพอง ผิวลอกพร้อมกับมีไข้หรือไม่มีไข้ แน่นหน้าอกหรือลำคอ หายใจเสียงดัง มีปัญหาในการหายใจหรือการพูด เสียงแหบ เป็นต้น
- ระดับน้ำตาลในเลือดสูง อาจมีอาการบ่งบอก เช่น สับสน รู้สึกร่างกายอ่อนแอ กระหายน้ำมาก หิวมาก ปัสสาวะบ่อย ผิวแดง หายใจถี่ หรือลมหายใจมีกลิ่นหวานคล้ายผลไม้
- โรคคุชชิง (Cushing's Disease) ซึ่งเป็นโรคที่ทำให้ไขมันสะสมเฉพาะร่างกายส่วนบน ผู้ป่วยอาจมีมวลน้ำหนักตัวบริเวณหลังส่วนบนหรือท้องเพิ่มขึ้น หน้ามนเป็นพระจันทร์ หรือปวดศีรษะรุนแรง
- มีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง เช่น สิวขึ้น ผิวแตกลาย และมีขนขึ้น รวมถึงการระคายเคืองบริเวณที่ใช้ยา

ปัจจัยของการกำเริบโรคสะเก็ดเงิน

- ความเครียด
- แพ้ฝุ่นไม่เพียงพอ นอนดึก
- การติดเชื้อบางชนิด ที่พบบ่อยคือติดเชื้อแบคทีเรียที่คอ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดอาการสะเก็ดเงิน
- การแกะและเกา
- การดื่มสุราและสูบบุหรี่
- น้ำหนักเกิน

ผลกระทบจากโรคสะเก็ดเงิน

- อาการคัน ไม่ถึงขั้นรุนแรง แต่สร้างความรำคาญ
- อาการผื่นตามผิวหนังอาจส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพ ทำให้สูญเสียความมั่นใจ
- หากเป็นนาน ๆ อาจมีอาการข้ออักเสบร่วมด้วย
- หากมีอาการทางข้อแล้วไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง อาจทำให้ข้อผิดรูปและพิการได้

ข้อควรปฏิบัติในผู้ป่วยสะเก็ดเงิน

- หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดการแห้งของหนังศีรษะหรือผิวหนัง
- หากเป็นน้อยสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ทั่วไปได้ โดยเลือกที่อ่อนโยนต่อผิว ทาโลชั่นให้ผิวชุ่มชื้นเป็นประจำ
- หากเป็นมาก ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่ออกฤทธิ์ช่วยลดการอักเสบ
- หลีกเลี่ยงการแกะหรือเกาผื่นสะเก็ดเงิน เพราะอาจทำให้อาการรุนแรงขึ้นและลุกลามได้

- พยายามอย่าเครียด ทำให้สบาย พักผ่อนและออกกำลังกายให้เพียงพอ
- หากติดเชื้อบางชนิด เช่น ติดเชื้อที่คอ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดสะเก็ดเงินได้ ควรรักษาอาการติดเชื้อโดยเร็ว
- หลีกเลี่ยงการดื่มสุราและการสูบบุหรี่
- ควบคุมไม่ให้มีภาวะน้ำหนักเกิน

Quiz

หญิงไทย อายุ 45 ปี น้ำหนัก 45 กก. อาชีพข้าราชการกรมสรรพากร เบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง ไม่มีโรคประจำตัว มีน้ำมูกใสๆ จากโรคหวัด ซึ่งเป็นมา 2 วัน รู้สึกรำคาญ ไม่มีอาการแน่นจมูก คำแนะนำและการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยรายนี้ คือข้อใด

1. ไม่ต้องใช้ยา เพราะหวัดเป็นโรคที่หายได้เอง
2. ให้ Telfast® 1 เม็ด วันละครั้ง ก่อนนอน
3. ให้ Nasotap® (brompheniramine + phenylephrine) 1 เม็ดวันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร และเตือนว่ากินยาแล้วอาจง่วงได้
4. ให้ chlorpheniramine 1 เม็ด ทุก 6 ชั่วโมง prn เมื่อมีน้ำมูก และเตือนว่ากินยาแล้วอาจง่วงได้

เฉลย 4.

เหตุผล ผู้ป่วยมีอาการที่รบกวนคุณภาพชีวิต จึงมีข้อบ่งชี้ ให้ใช้ยา Non-sedating antihistamine

แต่เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้นานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ หลีกเลี่ยงการใช้ยาผสม เพราะสามารถใช้ยาเดี่ยวทดแทนได้ Sedating antihistamine อาจลดน้ำมูกได้บ้าง แต่ต้องชั่งน้ำหนักกับผลข้างเคียง เช่น อาการง่วง

ประเด็น RDU ที่ประเมิน ข้อบ่งชี้ การใช้ยาสอดคล้องกับตำราหรือแนวทางเวชปฏิบัติประสิทธิผลของยา ความเสี่ยงจากการใช้ยา